



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ام هاشم عبد الله حفني عوض
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 28006052101127 رقم التليفون : 01099116946
العنوان : البدرشين
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-06-1980 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط اول تاموكسيفين
قسم العلاج :
الاورام

[14160]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ام هاشم عبد الله حفني عوض National ID: 28006052101127	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



دولة الكويت
الجمهورية العربية الإسلامية
الكويتية

م. حشيم
عبدالله حشيم عوض
تربية ستار
مركز التميز - الجفرة

٢٨

٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٣٧

KP7536103



٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٣٧



م. حشيم
عبدالله حشيم عوض
تربية ستار
مركز التميز - الجفرة



٢٨

٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٣٧

٢٨

Patient Name	: الأم فاطمة عبدالله حناني	Request No.	: 13003068
Patient Mo.	: 28006052101127	Request Date	: 09/03/2024
Path No.	: 969/24	Verification Date	: 24/03/2024
Sex	: Female	Financial Category	: دم - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa moh

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post NACT.

Source of the specimen: Left MRM, collected at 7/3/2024.

Gross Examination:

Procedure: Left MRM specimen measured 26x16x5 cm, covering skin ellipse measured 15x15 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.

Tumor extent

Number: Two ill defined grayish white TBS. 1.5 cm from each other.

Size: 3x1.5x1.5 cm and 3x2x1 cm.

Lymph involvement: No

Distance from margins: 2 cm from deep margin

Lymph nodes number and size: 8 nodules up to 3 cm.

Additional pathologic findings: N/A

Immunohistochemistry technique: N/A

Frozen section: N/A

Microscopic examination:

Histological type: No remnants of tumor tissue

Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): N/A

Angiolymphatic invasion: Negative

Ductal carcinoma in situ: No

Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/8).

Resection Margins: Free

Biologic response to therapy: PCR

Additional pathologic findings: Free nipple.

Diagnosis:

Verified by :

walaa ghoniem

Print Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 1 of 2

Printing By : marwa moh

CAP
ACCREDITED

شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: ام هاشم عبدالله حفني		
MR. : 4629		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was initiated on tamoxifen 20 mg daily, calcium supplementation (1 tablet daily for 90 days), and a single dose of zoladex 10.8 mg administered subcutaneously. Tamoxifen therapy was continued with supportive care for an additional three-month course, as documented for BSM in August 2026. The patient's pathology demonstrated invasive ductal carcinoma, estrogen receptor score 0/8, progesterone receptor score 8/8, HER2 score 3+, clinical stage T3 N2, with >4 cm tumor size, treated with neoadjuvant therapy (TXT + HP) followed by left total mastectomy (MRM) showing no residual tumor tissue. Multidisciplinary discussion in April 2024 concluded that the patient had completed 17 cycles of Phesgo, received postoperative radiotherapy, and was planned for five years of tamoxifen (nolvadex) followed by five years of an aromatase inhibitor. The patient started hormonal therapy in May 2024. The patient has completed 17 cycles of Phesgo.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	19-09-2026 التاريخ :
	يمنى امجد خالد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / أم هانم عبدالله جفلى
Patient No. : 28006052101127
Request No. : 13003068
Request Date : 09/03/2024
Verification Date : 24/03/2024
Financial Category : نفقة الدولة - رام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed you
Age : 43 Y
Sex : Female
Referring Doc :

Pathology Report

For breast cancer, post NACT; Left MRM:
No residual tumor tissue
Free nipple
Free deep margin
Free axillary lymph nodes (0/8)
pT0 ypN0.

Dr. Rana Fathy
Dr. Walaa Ghoniem

Verified by :
walaa ghoniem

Print Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed yous

Patient Name : الأستاذة / أم هانم حمد الله حفاي
Patient No. : 28006052101127
Age No. : 1372/2023
Sex : Female
Age : 42 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13003232
Request Date : 10/05/2023
Verification Date : 21/05/2023
Financial Category : نفقة الدولة - اورام حار السلام
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Ref Data: Left breast mass.

Ref of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Examination:
Fresh white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
Histological type: Invasive duct carcinoma.
(differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
In situ carcinoma: No.

Ductal invasion: No.

Invasion: No.

Immunohistochemical pathologic findings:

Positive control showed appropriate reactivity:

Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).

Strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).

Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).

Strong nuclear reaction of tumor cells.

Ref: Left breast mass, Tru-cut biopsy.
Histological type: Invasive duct carcinoma, GII.

Verified by:
DR. Menna Nabil

Date: 21/05/2023 10:31:59

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Patient Name	الأستاذة / ام هاشم عبدالخالق حناي	Request No.	13003232
Patient No.	28006052101127	Request Date	10/05/2023
Path No.	1372/2023	Verification Date	21/05/2023
Sex	Female	Financial Category	ار السلام - نفقة الدولة
Age	42 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 21/05/2023 10:31:59

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed yi

Patient ID:

1- Name: ام هاشم شريانه حنفي عوض

Sex:

MDT form

3- Medical number:
Female

83144545

Old Med:

Q&A Med

1983-2023

Patient Age: 44 Y

2-ID number: 28005052101127

Family history

Family history
-ve

Phone

Phone
01063842427

BMI

BMI

REASON OF MDT

Reason of
MDT

Marital status

Marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

16/04

Co morbidity

Co morbidity
-veMenopausal
statusMenopausal status
Menopausal

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX
IOC

BX - SNAPSHOT

ER
8/8

ER COMMENT

PR
8/8

PR COMMENT

Her 2 Neu
3

Her 2 Neu COMMENT

SISH

SISH COMMENT

Ki67
18T
3N
2M
0

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 2O'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER

4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTYERE/CARBOPLATIN/
HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with go
clinical response

LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins

free axillary LN C/8

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

NAME: Om Hashem Abd Allah

DATE : 4-08-2023

Referred by Prof. Dr.: «Professor»

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS:

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitory lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- RT ovary show oval shape cyst about 40x30mm showing thin wall and low density content
- Normal appearance of uterus ad LT ovary
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- Normal post contrast CT chest study.
- Normal post contrast CT abdomen study
- RT ovarian small benign looking cyst for follow up

*Kindly Accept My Best Wishes,
Dr. Ahmed Daraka, FRCR*



Patient's Name:

Umm Hashim Abdullah Hifni Awad

Date:

2026-08-04

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM routine follow up.

Findings:

Right breast

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>> all over area about 11x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
- No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>> all over area about 116x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
 - No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM

Patient's Name:

Umm Hashim Abdullah Hifni Awad

Date:

2026-08-04

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM routine follow up.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

جمهورية مصر العربية
بطاقة تعقب الشخصية

ام هاشم
عبدالله حفنى عوض
سقاره
مركز البدرشين - الجيزه

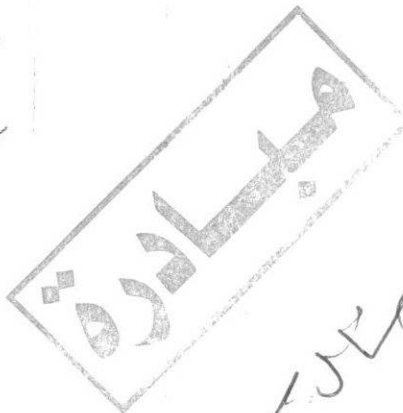
٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

GX2572218



ERM036726187

١٩٧٢
٥٢



٨٤٤٤٤٤٤٤

٢٠١٧/٠٢ ٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

رية منزل

أنثى مسلمة متزوجة
رضا محمد ابراهيم ابوشاهين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٦

٢٠١٥/٢١



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 05/05/2025
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *enlarged in size (17cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- *Average distention and capacity with no stones or mud*
- *The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

- *Average size, homogenous.*

Kidneys: -

- *Duplex right kidney with suspected lower malrotated the left kidney is ectopic*
- *Both are average in size, shape and echogenicity*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

Para-aortic and pancreatic area: *show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones or diverticular out pouching*

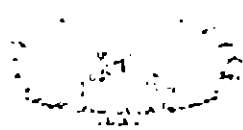
Uterus and adnexal: *no abnormalities could be detected*

Opinion:

Hepatomegaly
Duplex right kidney
Ectopic left kidney
Colonic gaseous distention

Signature Dr . Nermien Ramadan

05/05/2025 2:14 PM



Ministry of Health and Population
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة والسكان
الجمهورية العربية السعودية



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: أم هاشم عبدك جنتي نوح

Sex:

3- Medical numbers:

Female

83144545

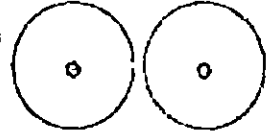
Old Med:

Date of MDT:

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age: 44 Y



Family history	Family history	Phone	Phone	DN1	DN1	REASON OF MDT	REASON OF MDT
-VE	-VE			01063842427			REASON OF MDT
Marital status	Marital status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT
							16/04/2024
Comorbidity	Comorbidity	Menopausal status	Menopausal status	Initial STAGE	Initial STAGE		
-VE	-VE						

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

BX IDC	ER 8/B	PR 8/B	Her 2 Neu 3	SISH	K167 15
ER COMMENT	ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM

IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER

4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/

HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with good clinical response

LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins

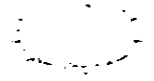
free axillary LN 0/8

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI + Zoladex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Patient Name	الأستاذة / ام هاشم عبدالله حنفى	Request No.	13003232
Patient No.	28006052101127	Request Date	10/05/2023
Path No.	1372/2023	Verification Date	21/05/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	42 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr.Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :

Printing Date : 21/01/2024 13:25:04

Page 2 of 2

Printed By : Dr.Marwa mahmoud



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cuiro, Egypt



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : أم هشام عبدالله حنظل عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

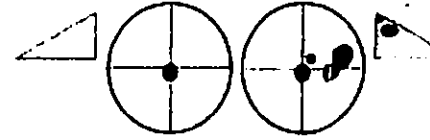
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

010999116946

BMI

REASON OF MDT

NEW

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

2023-06-14

Co morbidity

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CT RT OVARIAN SMALL BENIGN LOOKING CYST

BX:

IDC

ER:

8/8

PR:

8/8

Her 2 Neu :

3

SISH :

KI67 :

18

GII,,LT

T

N

M

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

start zoladex +NACT (ACx4 then Taxotere x4) guided by clinical response then consider LT MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د. هادي لامين	RADIOLOGY	د. هادي لامين
SURGERY	د. هادي لامين	PATHOLOGY	د. هادي لامين
Psychiatric		Nutrition	

Echo report

Name: محمد علي

Date: 15/11/2024

MR: 1982
CX

EF	70%	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	5	3.5-5.8cm	AO.R	2.2	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA SWMA

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve normal morphology Tick TR

Aortic valve normal

Tricuspid valve TR

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د/مبا علي

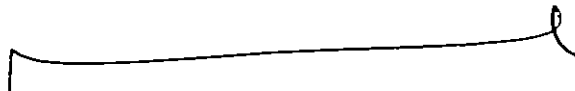
1982
٢٢

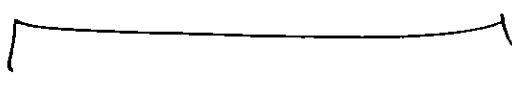
وزارة الصحة والسكان
امانة المستشفى الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

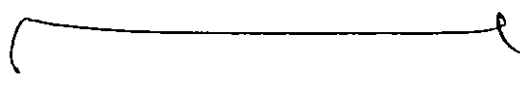
Dr. / محمد عبد الله حفيظ **Echo report**

No
D: 15/1/2023

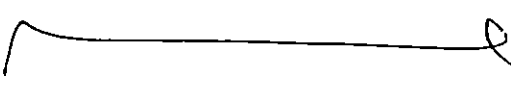
EF	65%	55-75%	PWT		0.6-1.1cm
VEDD	4.6	3.5-5.8cm	AO.R	3.0	2-3.7cm
VESD	2.9	2-4cm	LA	3.0	2-4cm
FS	35%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
PWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

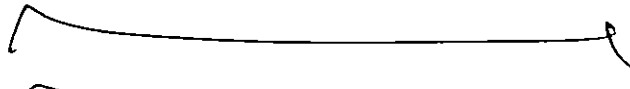
LV dimensions 

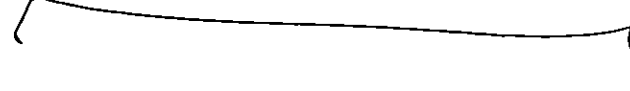
LV wall thickness 

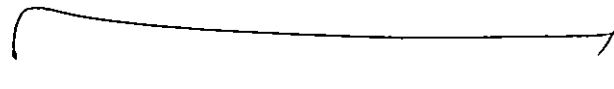
LV systolic function 

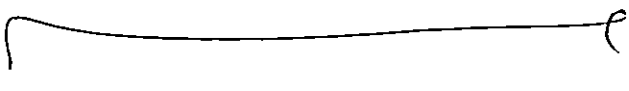
SV No RWMA at rest

LA Aortic root dimensions 

Mitral Valve 

Aortic valve 

Tricuspid valve 

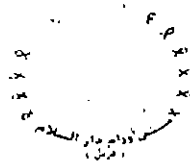
Primary valve 

Right side and systolic function 

Intracardiac masses and effusion No

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>>> all over area about 116x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
- No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM



عاشق عبد الله حفيظ
11/2 Echo report

Name:

Date: 7/10/2023

MR: 1912/CT

EF	64%	55-75%	PWT	9.96	
LVEDD	4.58	3.5-5.8cm	AO.R	2.12	2-3.7cm
LVESD	2.99	2-4cm	LA	3.13	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.96	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

Normal

LV wall thickness

Normal

LV diastolic function

Normal

SWMA

No SWMA

LA and Aortic root dimensions

Normal

Mitral Valve

Normal

Aortic valve

Normal

Tricuspid valve

Normal

Pulmonary valve

Normal

Right side and systolic function

Not Dilated, Normal function

Intracardiac masses and effusion

No effusion, no masses

D/ Msc cardiology

Dr. Khaled



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : اد هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

83144545

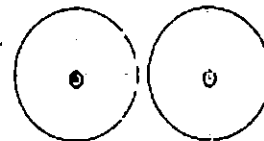
Old Med :

Old Med :

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age: 44 Y



Family history

Family history
-ve

Phone

Phone

01063842427

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

16/04/2024

Co morbidity

Co morbidity
-veMenopausal
statusMenopausal Status
PRE MENOPAUSA

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX
IDCER
8/8PR
8/8Her 2 Neu
3

SISH

KI67
18

BX COMMENT:

ER COMMENT

PR COMMENT

Her 2 Neu COMMENT:

SISH COMMENT:

T
3N
2M
0

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER
4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/
HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with good
clinical response

LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins
free axillary LN 0/8

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutr.Lon



Patient Name : الأستاذ / أم هاشم عبدالله حنفى	Request No. : 13003068
Patient No. : 28006052101127	Request Date : 09/03/2024
Path No. : 969/24	Verification Date : 24/03/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post NACT.

Nature of the specimen: Left MRM, collected at 7/3/2024.

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM specimen measured 26x16x5 cm, covering skin ellipse measured 19x13 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.
- Tumor extent
- Number: Two ill defined grayish white TBS. 1.5 cm from each other.
- Size: 3x1.5x1.5 cm and 3x2x1 cm.
- Skin involvement: No
- Distance from margins: 2 cm from deep margin
- Lymph nodes number and size: 8 nodules up to 3 cm.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A

Microscopic examination:

- Histological type: No remnants of tumor tissue
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): N/A
- Angioinvasion: Negative
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/8).
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: PCR
- Additional pathologic findings: Free nipple.

Diagnosis:

Verified by :
walaa ghoniem

Printing Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

CAP
ACCREDITED

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / أم هاشم عبدالله حفي	Request No. : 13003068
Patient No. : 28006C52101127	Request Date : 09/03/2024
Cash No. : 969/24	Verification Date : 24/03/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Left breast cancer, post NACT; Left MRM:
- No residual tumor tissue
- Free nipple
- Free deep margin
- Free axillary lymph nodes (0/8)
- ypT0 ypN0.

Dr. Rana Fathy
Dr. Walaa Ghonaim

Verified by :
walaa ghoniem



Patient Name : الأستاذة / أم هاشم عبدالله حنفى :

Request No. : 13003232

Patient No. : 28006052101127

Request Date : 10/05/2023

Path No. : 1372/2023

Verification Date : 21/05/2023

Sex : Female

Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة

Age : 42 Y

Department : Out Patient

Referreing Doc. :

IHC No. :

Registered by : .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Additional pathologic findings:
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 18 % nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, GII.

IPT:

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 31/05/2023 10:31:59

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss



Patient Name الأستاذة / ام هاشم عبدالله حفي
Patient No. 28006052101127
Path No. 1372/2023
Sex Female
Age 42 Y
Referring Doc.

Request No. 13003232
Request Date 10/05/2023
Verification Date 21/05/2023
Financial Category اورام دار السلام - نفقة الدولة
Department Out Patient

Registered by .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :
DR. Menna Nabil

NAME: Om Hashem Abd Allah	DATE : 4-06-2023
Referred by Prof. Dr.: «Professor»	

**MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS:**

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- RT ovary show oval shape cyst about 40x30mm showing thin wall and low density content
- Normal appearance of uterus ad LT ovary
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- Normal post contrast CT chest study.
- Normal post contrast CT abdomen study
- RT ovarian small benign looking cyst for follow up

*Kindly Accept My Best Wishes,
Dr. Ahmed Daraka, FEBR*



Patient Name	: الأستاذ / ام هاشم عبدالله حنفى	Request No.	: 13003232
Patient No.	: 28006052101127	Request Date	: 10/05/2023
Path No.	: 1372/2023	Verification Date	: 21/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Additional pathologic findings.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 18 % nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, GII .

IPT:

Verified by :



NAME: Om Hashem Abd Allan	DATE : 4-06-2023
Referred by Prof. Dr. Professors	

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary ducts dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- RT ovary show oval shape cyst about 40x30mm showing thin wall and low density content
- Normal appearance of uterus and LT ovary
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- Normal post contrast CT chest study.
- Normal post contrast CT abdomen study
- RT ovarian small benign looking cyst for follow up.

*Kindly Accept My Best Wishes,
Dr. Ahmed Daraka, FEBR*

Patient Name: *Om Hoshem Abd Allah Hefny*
Prof. Dr: *Center harmful*
Accession: *23082406*

Patient ID: *607255*
Exam Date: *24/8/2023*

^{99m}Tc-MDP whole body bone scan

History:

43-year-old female patient has managed breast cancer for assessment of bone.

Physical examination:

Skeletal surveying:

Technique:

*Anterior and posterior Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V
administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP;*

Findings:

General appearance:

*Degenerative changes are noticed in the dorsal & lumbar vertebrae as well as both knee
joints.*

*There is no hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the
surveyed skeleton.*

Both kidneys are visualized.

CONCLUSION:

The surveyed skeleton is free from definite osseous deposits

Best regards:
Dr. Huda Fathy M.D.



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM

/ / 20

G

Name	ام هاشم عبدالله فتحي عوض	MRN	1983 / 2023
		ID	13122020
Age	44	Phone	01063842427
Menopausal status	pre	Marital status	1-99971-VE
NRS SCORE		Family history	-ve
BMI		REASON OF MDT	Post surgical (T.M.M.)
CO morbidity	-ve		1-99117927

Clinical Data

BX: IDC	R	L
ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: 3
Ki67: 18		
Sonammammography: Lt Uoq multifocal mass at 2'clock 4.6x2.8cm 304cm 2x2.4 Multiple satellite 7x6.4mm		
Mets Workup:		

Recommendations:

Post NACT = Lt MRM No residual tumor tissue + Free nipple +
Free deep margin - Free axillary LN (0/8) To No

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



Echo report

ام هادي عبد الله حبي

MR: 1983
23

Name:

Date: 15/2/2024

EF	66 %	55-75%	PWT		
LVEDD	4.4	3.5-5.8cm	AO.R	3.3	2-3.7cm
LVESD	2.8	2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS	34 %	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.1	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function

SWMA NO SWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion NO

D/Mohamed Ali

Msc cardiology



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

**MDT form**

A-Patient ID:

1- Name : ام هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

83144545

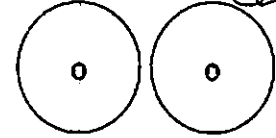
Old Med :

Old Med :

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 44 Y



Post-NAC
clinical

Family history	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT
			01063842427				POST NACT
marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date Of MDT
					A		07/02/2024 ☐
Co morbidity	Co Morbidity	Menopausal status	Menopausal Status	Initial STAGE	Initial STAGE		
	free						

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup :
------------------	---------------

BX IDC	ER 8/8	PR 8/8	Her 2 Neu 3	SISH	Ki67 18
BX COMMENT:	ER COMMENT:	PR COMMENT:	Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :	

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 2O'CLCOK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER
4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA
IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/

MDT OUTCOME & PLAN**MDT OUTCOME & PLAN**

for LT MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ نهاده لاشين	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ زهنام نور
SURGERY	SURGERY د/ ابراهيم الزويك	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Patient Name	الأستاذة / ام هانم عبدالله حنفى
Patient No.	2830605213-127
Path No.	1372/2023
Sex	Female
Age	42 Y
Referring Doc.	

Request No.	13003232
Request Date	10/05/2023
Verification Date	21/05/2023
Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الولة
Department	Out Patient
Registered by	marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 31/05/2023 10:31:59

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي



Patient Name	الأستاذة / ام هاشم عبدالله حفتي	Request No.	13003232
Patient No.	28006052101127	Request Date	10/05/2023
Path No.	1372/2023	Verification Date	21/05/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	42 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

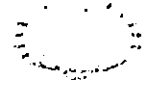
Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 31/05/2023 10:31:59

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss



Patient Name	: الأستاذة / ام هاشم عبدالله حنفى	Request No.	: 13003232
Patient No.	: 28006052101127	Request Date	: 10/05/2023
Path No.	: 1372/2023	Verification Date	: 21/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة التولية
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Additional pathologic findings:
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 18 % nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, GII .

IPT:

Verified by :

DR.Menna Nabil



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : ام هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

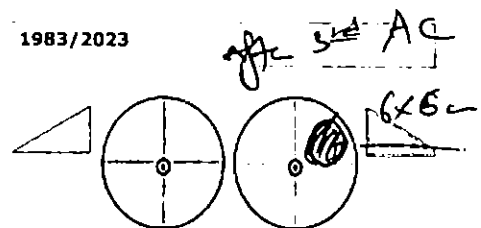
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

01099116946

BMI

31

REASON OF MDT

REMDT

marital status

NRS Score

1

GROUP

A

Date of MDT

2023-08-23

Co morbidity

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CT RT OVARIAN SMALL BENIGN LOOKING CYST

BX: IDC LT GII	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu : 3	SISH :	KI67 : 18
----------------------	------------	------------	------------------	--------	--------------

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLCOK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 14/6/2023--> start zoladex + NACT (ACx4 then Taxotere x4) guided by
clinical response then consider LT MRM.

pt received 3 cycles AC LAST ON 17/08/2023 WITH QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
FOR BONE SCAN

MDT OUTCOME & PLAN

DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM

IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER 4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA
IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES
THEN LT MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/محمود لاسين	RADIOLOGY	د/محمود لاسين
SURGERY	د/ابراهيم عبدالرحمن	PATHOLOGY	د/ابراهيم عبدالرحمن
Psychiatric		Nutrition	د/ابراهيم عبدالرحمن



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

3- Medical number:

83144545

1- Name : ام هشام عبدالله حنفي عوض

Sex:

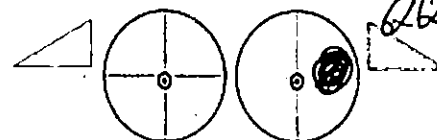
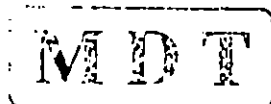
Female

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

01099116946

BMI

31

REASON OF MDT

REMDT

marital status

NRS Score

1

GROUP

A

Date of MDT

2023-08-30

Co morbidity

Meno-pausal
status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX: IDC LT GII	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu : 3	SISH : 	Ki67 : 18
----------------------	------------	------------	------------------	------------	--------------

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER
4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA
IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/
HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES
THEN LT MRM

MDT OUTCOME & PLAN

sonomammography show disease progression so shifted to taxotere/carboplatin/herceptin/perjeta

6-8 cycles

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/نبينا لاشين	RADIOLOGY	د/نبينا لاشين
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : ام هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

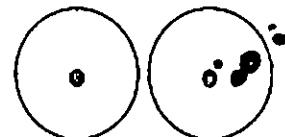
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

01099116946

BMI

REASON OF MDT

NEW

marital status

NFS Score

GROUP

A

Date of MDT

2023-06-14

Co morbidity

Menopausal
status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CT RT OVARIAN SMALL BENIGN LOOKING CYST

BX: IDC GII,,LT	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu : 3	SISH :	KI67 : 18
-----------------------	------------	------------	------------------	--------	--------------

T 3	N 2b	M
--------	---------	---

Sonomammography

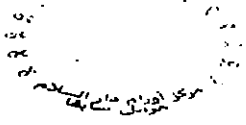
LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

start zoladex +NACT (ACx4 then Taxotere x4) guided by clinical response then consider LT MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د. هاشم عبدالله حنفي عوض	RADIOLOGY	د. هاشم عبدالله حنفي عوض
SURGERY	د. هاشم عبدالله حنفي عوض	PATHOLOGY	د. هاشم عبدالله حنفي عوض
Psychiatric		Nutrition	



Echo report

Name: أم هاشم عبد الله

Date: 27/8/2024

MR: 1782
٢

EF	72%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.4	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.3	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LVDimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA normal

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve trivial TR with RSP 21 mmHg

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د. مياح



• **طبيعة العلاج الكيميائي المقدم وطرق تلقي العلاج.**

- وهذا إقرار مني بذلك بكون أنتي مسؤولة على الطبيب أو الطاقم الطبي.

أقر بهذا وأوقع عليه

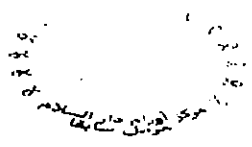
توقيع المريض (او من ينوب عنه) :
.....

..... اسم الشاهد التوقيع

اسم الطبيب:
 التوقيع:

التاريخ: 20 / 1 / 1442 هـ الوقت:

ملحوظة: يتم تغيير الإقرار عند تغيير برتوكول العلاج



Echo report

Name: ام هاشم عبدالو

Date: 27/8/2024

MR: 1783
C5

EF	72%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.4	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.3	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LVDimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA normal

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve trivial TR with RSP 21 mmHg

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د. صالح



Patient Name : أم هاشم عبدالله حفني
Patient No : 1983-2023
Sex : Female Age : 44 Y
Financial Cate : نفقة الدولة - أورام دار السلام
Department : Out Patient
Referring Doc :

Lab No. : 13009106
Request Date : 06-08-2024 08:53
Verification Date : 06-08-2024 10:12
Sample Type : EDTA Blood
Test Status : Routine
Analyzers : XN350_herml

Complete Blood Picture

Test	Result	Unit	Ref. Range
Hemoglobin	<u>11.4</u>	g/dL	12.0 - 16.0
RBCs	<u>3.7</u>	$10^6/\mu\text{L}$	4.0 - 6.5
Haematocrit (PCV)	<u>33.2</u>	%	36.0 - 50.0
MCV	88.8	FL	76.0 - 101.0
MCH	30.5	pg	26.0 - 32.0
MCHC	34.3	g/dL	31.5 - 34.5
RDW-CV	13.7	%	11.6 - 14.0
PLT	216	$10^3/\mu\text{L}$	150 - 450
WBCs.Total	4.3	$10^3/\mu\text{L}$	4.0 - 11.5

Differential Leucocytic Count :

	Relative		Absolute		
Neutrophils%	61.6	%	2.65	/cmm	2.00 - 7.00
Lymphocytes%	25.8	%	<u>1.11</u>	/cmm	1.50 - 3.50
Monocytes %	10.0	%	0.43	/cmm	0.20 - 1.00
Eosinophils %	2.1	%	0.09	/cmm	Up to 0.50
Basophils %	0.5	%	0.02	/cmm	Up to 0.10

Signature

Nouran Emad

Printing Date : 06/08/2024 10:53:56

Page 1 of 1

Printing By : hermal

25311121 / فاكس

25311128

- 25311125 / ت

987 كورنيش النيل الملك الصالح



Patient No. : 1983-2023
Patient Name : الأستاذة / ام هاشم عبدالله حنفى
Sex : Female Age: 44 Y
Financial Cate : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13009106
Request Date : 06-08-2024 08:53
Verification Date : 06-08-2024 10:47
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers : biolis_hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range	
ALT (SGPT)	23.3	U/l	Up to 31.0	)
AST (SGOT)	18.3	U/l	Up to 31.0	)
Serum Creatinine	1.0	mg/dl	0.6 - 1.2	)
Uric acid	<u>6.7</u>	mg/dl	2.6 - 6.0	)
Urea	39.9	mg/dl	17.0 - 43.0	)
Calcium Ionized (Ca++)	1.18	mmol/l	1.10 - 1.30	)
Bilirubin Total	0.72	mg/dl	0.10 - 1.20	)
Bilirubin Direct	0.08	mg/dL	Up to 0.20	)

Signature

Nouran Emad

Printing Date : 06/08/2024 10:53:55

Page 1 of 1

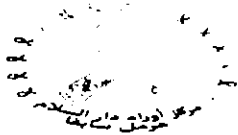
Printing By : hermal

25311121 / فاكس

25311128

- 25311125 / ت

987 كورنيش النيل الملك الصالح



Echo report

Name: ام فاطم عبدالله

Date: 7/5/2024

MR: 19/12/22

EF	71%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.9	3.5-5.8cm	AO.R	2.4	3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

- LVDimensions normal
- LV wall thickness normal
- LV diastolic function normal
- SWMA no SW, TR
- LA and Aortic root dimensions normal
- Mitral Valve normal
- Aortic valve normal
- Tricuspid valve Tild TR
- Pulmonary valve normal
- Right side and systolic function normal
- Intracardiac masses and effusion no

D/Msc cardiology
ف. ع. ع.

Patient Name: OM HASHEM ABDALLA	Patient ID: 20230828-124550PM
Study Date: 8/28/2023	Age:

Opinion:

- Left UOQ pathologically proven malignant lesions, wit multi centric satellites as above described. the index lesions show progressive course regarding the size.
- Left axillary Level 1, two suspicious lymphnodes.
- Right breast mild fibro adenosis (BIRADS 2).

Dr. Yasmin Essam Khalifa, MD

Women imaging

Date & Time: 8/28/2023 1:36:19 PM

Women's Health Outreach Program

Name : Om Hashim Abdulla Hanafy

Date: 9/5/2023

Bilateral Full field Digital Mammography

Technique:

Mediolateral oblique and CC views

High resolution ultrasound

Clinical summary : Left breast swelling few months ago in 42 years old patient with positive family history

Detailed Findings:

left breast:

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma (ACR b).
- UOQ shows multiple spiculated solid mass lesions with suspicious microcalcifications
- Ultrasound UOQ is the seat of multiple ill defined heterogeneous solid mass lesions as follow :-
 - At 2 o'clock measures 4.6x2.8 cm 5 cm from nipple 7 cm from skin .
 - at 3 o'clock measures 2.2x2.4 cm with near by another mass measures 2x1.7 cm
 - multiple satellites measures 7x6.4 mm (3 cm from nipple) , 10x7 mm (2 cm from nipple) .
 - Axillary tail measures 9x5 mm .
- One axillary pathological L.N seen at level I measures 1 cm with lost hilum .
- One infra-clavicular measures 9x5 mm with preserved hilum .
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- ~~Non-specific axillary LNs .~~

Right breast:

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma (ACR b).
- No masses asymmetric densities , distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- ~~UOQ is the seat of two well-circumscribed nodules .~~
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesion .
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs .

Impression :

- left breast (BIRADS 5) : UOQ multifocal malignant solid mass lesions with pathological axillary LNs level I and III for biopsy and histopathological correlation .
- Right breast (BIRADS 1) : Normal study

Best regards,

Dr/Nashwa A. El Kader

well-circumscribed nodules
solid or cystic lesion

pathological
histopathological correlation

Bilateral Mammography and High resolution Breast Ultrasound Revealed

Complaint: Follow up on pathologically proven left UOQ IDC on neo adjuvant treatment.

Findings:

- Heterogeneous dense breast (Acr c).
- Left UOQ irregular speculated dense lesion with segmental area pleomorphic micro calcifications measuring about 6.5x3.8 cm.
- No dominant masses or suspicious microcalcifications in the right breast.
- Complementary ultrasound revealed
- Left 2:00 midzonal irregular speculated hypoechoic lesion measuring 5.6x3x4.5 cm, with near by satellite measuring 0.6x0.5 cm.
- Left 3:00 irregular speculated hypoechoic lesion with internal micro calcifications, measuring 2.2x1.2x2.6 cm.
- multi centric satellites are seen as rounded hypoechoic lesions with angulated and indistinct margins seen at:
 - 11:00 para areolar: 0.5x0.4x0.4 cm
 - 10:00 para areolar: 0.9x0.7x0.9 cm
 - 5:00 mid zonal deep: 0.5x0.4x0.4 cm
 - retro areolar: 0.45x0.4x0.4 cm.
- No right solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complex.
- Right non specific axillary lymph nodes.
- Left small globular sub centimetric lymphnode with lost hilum is noted and another one with preserved hilum yet showing diffuse cortical thickening reaching 2.4 mm in thickness.
- No pathologically enlarged infra or supra clavicular lymphnodes.

1913
ع. ع. ع.
ام هاشم عبد الله

Patient Name: CM HASHEM ABDALLA	Patient ID: 20230828-124550PM
Study Date: 8/28/2023	Age:

Opinion:

- Left UOQ pathologically proven malignant lesions, wit multi-centric satellites as above described. the index lesions show progressive course regarding the size.
- Left axillary Level 1, two suspicious lymphnodes.
- Right breast mild fibro adenosis (BIRADS 2).

Dr. Yasmin Essam Khalifa, MD

Women Imaging

Date & Time: 8/28/2023 1:36:19 PM

[illegible]



إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		26/7/2025 : PA U/S live postprandial Duplex RA feeding Echocardiography R. Zaladex 100 mg R. Naloxone 20 mg (x1) R. G. Alfentanil 100 mg R. Calcein 100 mg Dr. [Signature]	س. ع. ع. ع. 17/8

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمثلة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

~~ER 8/8~~

PR 8/8

$$\frac{he^{12}}{+3}$$

نوع التغذية :

التشخيص:

Adj: phesgo

Polystyrol
Nolvadex

C17

توقيع الطبيب

الأوامر

لوقت

التاريخ

.....	عنسيحجو.....7.....	عنت الحلسد
.....	تامو فشتب ؟	
.....	كالمسيوم	يوعميا لمسد
.....	وان الفنا	شلا شله شهر

— ۱۰۰ —
ع. ق. ا. ع. ا. ع.

C16 pheryo
صا عسریل
C.co/c/co

وولد له	٨ أبناء	أولهم أحمد بن محمد بن علي
ثانيهم	عبد الله بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
ثالثهم	علي بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
رابعهم	محمد بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
خامسهم	إبراهيم بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
سادسهم	يحيى بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
سابعهم	إسماعيل بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
ثامنهم	عيسى بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
تاسعهم	الحسين بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي
عاشرهم	الفضل بن محمد بن علي	بن علي بن عبد الله بن علي

منیر. علی

S.m. (R)

C.C. 10/4

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

التشخيص: **نوع التغذية:**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-012
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2023

اسم المريض ثلاثي: محمد بن عبد الله
رقم الملف: ١٩٨٤١

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص:..... نوع التغذية:.....

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف: ١٦٨٣/٤٣



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

ام هاج عبد الله

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
27/8/2024		ECHO EF 722 (27/8/2024) C11 phes 27/8/2024 دا ا م فز	
17/9/2024		C12 phes 17/9/2024 دا ا م فز	

جميع الأوامر الطبية لا بد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
	C10	(ECHO requested) فريق التصوير (C) ٢٠١٧ تأثير من (C) ٢٠١٧ Cbc, wbs ok D/L ٢٠١٧	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام " هرمل "
ادارة الجودة

.....: نوع التغذية:: التشخيص:

C.C. 14/17

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام " هرمل "
ادارة الجودة



اسم المريض ثلاثي: ام مكيه عبد الله
رقم الملف: ٤٩٨٢ / ٥

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: نوع التغذية: EF 5/2024: 71 %

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
C6	17:00 - 18:00	تأهيل المريض إلى المستشفى للمتابعة بعد 24 ساعة من الجراحة	د. محمد 14/5/2024 صباح
C7	18:00 - 19:00	تأهيل المريض إلى المستشفى للمتابعة بعد 24 ساعة من الجراحة	د. محمد 14/5/2024 صباح

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة ومفهومة من الطبيب /

بار و کرم
و اسم است (مع)

7/2/11

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

.....: نوع التقنية:: التشخيص:

法蘭西

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

10.8

CS phesgo
23/5/2020
2020/5/23

Page 6 of 6

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders اوامر الطبيب

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة ومفهومة من الطبيب

۲۴ ص ۱۰۵
۱۹ ص ۱۰۵

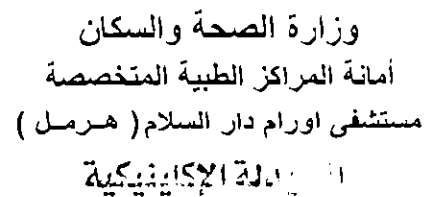
SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
المسئولة الإكلينيكية

carb
Docetaxel + Trastuzumab + Pertuzumab Q 3 weeks Cycle (...)

التاريخ: 2022/11/11		اليوم:	
رقم الملف:		اسم المريض: <i>أ.م. هاشم عبد الله خضر</i>	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: EF: %		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
امضاء التمريض	بروتوكول العلاج		الصرف
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
	هرتوزوماب مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة (علي مدي ساعة في الجرعة الاولى) Loading Dose: 840 mg Maintenance Dose: 420 mg		
	تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م) مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق <i>AUC 5</i>		
العلاج التذعيمي: ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة. <i>C6 TC (610mg)</i> <i>C6 TC</i> <i>تم صرف تاكسونيد كابريل</i>			
Physician Signature:	Clinical pharmacy: <i>علاج امبرج</i> <i>لهو عبد الكريم</i> <i>0.02/11/21</i>	Dispensing pharmacy:	



اليوم:		التاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠٤	
اسم المريض: أ.م. هاشم عيسى		رقم الملف: ١٩٨٢/٤٢	
Weight: 84 kg	Height: 165 cm	BSA: 1.96 M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: 15/6 EF: 65 %		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
	امضاء التمريض		
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron =1mg)		
	دوكسوروبيسين (60 مجم/م) ١.١.٠.٥ مجم في 100 مل ج 5% علي مدي 1/2 ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
	سيكلوفوسفاميد (600 مجم/م) ١.١.٠.٥ مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج التدعيمى:	كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. ديكساميثازون 8 مجم قرص يوميا من اليوم الثاني للرابع. ايمند قرص 125 مجم اليوم الاول و 80 مجم اليوم الثاني و الثالث. برسيف ٦ - ٢٠٠٠		
Dispensing pharmacy:	Clinical pharmacy:	Physician Signature:	



اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders الاوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		$Lt. CT_3 N_3 M_{act}$ $INDC Cr II$ $\hookrightarrow NACT = 4AC \rightarrow 4T_{act}$ $ER 818 PR 818 H_2 = 3$ $K_{act} = 18$ $\hookrightarrow C, AC$ $CC 17/55$	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

.....: اسم المريض ثلاثي:
.....: رقم الملف:

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

.....: نوع التغذية:: الشخص:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

رقم الملف: ١٩٨٢/٤٢٢

kur 2

اسم المريض ثلاثي: اسمها اسم بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الملف: ٢٣١٩٨٣



وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل"
إدارة الجودة

Doctor's Orders الأوامر الطبيب

التشخيص: نوع النخية:
ABW 67.7

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Patient printed today CK - Proge for Cycle (2) Toxotene 140.5 Cambophene AUCS Phasage 1200/600 Gile I Mutabizgen 1.2 Controler 400 Erond 1.2 Ondulez 5.0 Namozem 1.2 Amino Phyllin 1.2 27/10/2023 CentoxT + Carbos (512) 140 → Phesgo after Echo on 7/10/2023 (approved) Carph /	

بسم الله الرحمن الرحيم

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أروام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة



اسم المريض ثلاثي: ٥٤١ الحبيبة الد
رقم الملف: ٢٢١٩٨٢

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: نوع التغذية:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

.....:التشخيص::نوع التقنية:.....

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
العيادة الإكلينيكية

25/10/2021
don
reduct

Docetaxel + Trastuzumab Protocol Cycle (.....)

اليوم:		التاريخ: 2021 / /	
أسم المريض: ...		رقم الملف: ...	
Weight: 84 kg	Height: 165 cm	BSA: 1.96 M2	Age: 43 years
CBC:	WBC:	ANC:	Hgb:
PLT:	Functions Tests: Sr.Creat: 1.6 Urea: ...		
ALT:		AST:	T.Bil: ...
D.Bil: ...		CRA = 10.2	
Echo:	Date:	EF: ... %	
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
	امضاء التمريض		
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م2) 4.5 مجم في 500 مل ج 5% علي مدي 10 دقائق		
	50 مل ج 5% علي مدي 10 دقائق		
N.B: Trastuzumab SQ is given for Adjuvant setting Trastuzumab IV is given for MBC			
	☒ تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ. ☐ تراستوزوماب مجم علي 250 مل ملح لمدة نصف ساعة. (علي 500 مل ملح لمدة ساعة ونصف الجرعة الاولى فقط) Loading Dose: 8 mg/m2 Maintenance Dose: 6 mg/m2 (MAX: 440 mg)		
العلاج التديمي:			
كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع.			
ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة			
5 x 1 14 x 2			
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	

..... اسم المريض ثلاثي:
..... رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Age 43

wt 86

..... نوع التغذية:

116165

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
96	BSA	411116	
67	ARSA	for Neph + renal	
		C3	
		CBC - ok	
		5 Cues	
		Crit 11/4	
		Scr 7.6	
		Crcl 10.2	
		RE monitor	
		4.11.2022	
		Scr 7-6	
		UA 168	
		PH: 7.21	
		for Neph Cues	
		ICU Cues	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

for Neph Cues

ICU Cues

11/4

رقم الملف: ٢٢٢ / ١٩٨٢

EP 64.1.

7/10/23

Doctor's Orders **أوامر الطبيب**

نوع التغذية:

3 phesot 4 Te
dph
Volen
19 11
23

مستند
C. 4 / 19 / 4

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: $NACH_3$ نوع التغذية:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



إسم المريض ثلاثي:

..... رقم الملف:

.....التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		labs. → pending ليسوجد قرار استكمال لا phesgo ثم تبايعه ابر اليوم for C6 T-C	12/2023

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب